Downloaded from: justpaste.it/lsfdalr

LSFD RP

RADIO PROCEDURE

PAGER

Post: *PAGER* Positive from Fire Alrik.

Nega: *PAGER* Negative from Fire Alrik. /ro Maaf saya sebentar lagi mau off game karena mau pergi jadi tidak bisa on duty.

📻DEFAULT RADIO

OnDuty (/21): /r Fire Alrik reporting Status-2 on 10-20 DFS.

OffDuty (/22): /r Fire Alrik take Status-1 on 10-20 DFS.

BreakPatrol (/23): /r ~ clearing from Status-4, now taking Status-3 on 10-20 Legion.

StartPatrolDFS (/24): /r Fire Alrik under ~ reporting Status-4 clearing from 10-20 DFS.

RTB (/25): /r ~ clearing from Status-4, now RTB to 10-20 DFS.

Parked&Disb (/26): /r ~ has been parked and disbanded, Fire Alrik on Status-10 10-20 DFS.

📞OCD CALLING

MAIN to Field unit, 10-21 please.

RespPatrol: /r ~ is on Status-4 10-20 Legion.

RespBreak: /r ~ is on Status-3 10-20 Legion.

TakingScene: /r ~ taking Status-5e heading to 10-20 Legion with CODE-3, ETA 4 Minutes.

🚨SCENE PROC

OnLocation: /r ~ Status-6 on 10-20 Legion.

Loaded1 (/31): /r ~ Status-7e, bring one victim down with Fracture, please prepare ER. Now heading to 10-20 PBH with ETA 4 Minutes.

Loaded1 (/32): /r ~ Status-7e, bring one victim down with GSW, please prepare ER. Now heading to 10-20 PBH with ETA 4 Minutes.

Loaded1 (/33): /r ~ Status-7e, bring one suspect down with GSW, please prepare ER. Now heading to 10-20 PBH with ETA 4 Minutes.

Loaded1 (/34): /r ~ Status-7e, bring one suspect down with Fracture, please prepare ER. Now heading to 10-20 PBH with ETA 4 Minutes.

OnHospi (/35): /r ~ Status-8 10-20 PBH.

RTB (/36): /r ~ reporting 10-99 from Last Scene, now RTB to 10-20 DFS.

📢 MEGAPHONE CHAT

(/8) /megaphone LSFD EMERGENCY! Please clear the road!

Jarang Dipakai

Dep. Radio part1: Fire @ to LSPD/LSSD.

Dep. Radio part2: Please send your unit to Hospital, we have patient bring an ilegal items. **(Jarang Dipakai)**

ENGINE Support: ~ to OCD. Requesting 10-70e ENGINE Support at 10-20 Legion. **(Jarang Dipakai)**

FIELD PROCEDURE

✅DEFAULT PROCEDURE

(Kondisional)

(/51) /me segera melakukan pengamanan area sekitar agar aman dari ancaman lanjutan.

(Kondisional)

(/52) /me melepas atribut dan segala aksesoris dari kepala korban untuk mengantisipasi adanya cedera tambahan.

(Kondisional)

(/53) /me memindahkan tubuh korban untuk penanganan di lokasi yang lebih aman.

(/54) /me mengambil ILS Bag dari dalam unit kendaraan, kemudian berjalan cepat menuju korban.

(/55) /me meletakkan ILS Bag di samping korban, membukanya lalu mengeluarkan perangkat ECG dari dalam ILS Bag.

/fo -> Lifepack

.medic2

(/56) /me mengambil sepasang N-Gloves dari dalam ILS Bag lalu mengenakannya dengan rapi pada kedua tangan.

(/57) Halo, apakah bisa mendengar suara saya?

(/58) /me mencubit kulit korban dengan tangan kanan untuk memicu respon nyeri.

(/59) /do Apakah terlihat ada reaksi otot atau rasa nyeri dari cubitan?

/inspect [id]

🩻Kalau Bone Fracture

(/60) /me memeriksa tubuh korban dan menemukan adanya kemungkinan patah tulang pada tubuh korban.

(/61) /do Patah tulang jenis apa yang dialami korban? (Open Fracture / Close Fracture)

Kalo jawab CLOSE FRACTURE: A B C -> Broken Bone

Kalo jawab OPEN FRACTURE: RP Di bawah -> DEAT -> A B C -> Broken Bone

(/62) /me segera memulai prosedur penanganan D.E.A.T. untuk menghentikan pendarahan pada area patah tulang.

🔫**Kalau GSW**

(/63) /me menemukan adanya area bekas luka tertembak pada tubuh korban.

Lalu DEAT -> A B C

Prosedurnya disebut **X (Exsanguinating Hemorrhage)** dan cara penanganannya adalah dengan melakukan **DEAT**.

🩸BLEEDING PROCEDURE (DEAT) (GSW/Vital W., Flesh W., Open Frct.)

DIRECT PRESSURE

(/71) /me mengambil Trauma Scissor dari ILS Bag lalu menggunting pakaian korban yang menutupi luka.

(/72) /me mengambil Trauma Dressing dari ILS Bag lalu meletakkannya diatas luka korban sambil memberi tekanan.

(/73) /do Apakah pendarahan berhenti?

Jika belum

(/74) /me mengambil trauma dressing yang baru dari dalam ILS Bag.

(/75) /me melapisi kembali area pendarahan dengan trauma dressing yang baru.

(/73) /do Apakah pendarahan berhenti?

ELEVATION

(/76) /me mengangkat bagian tubuh korban yang mengalami luka lebih tinggi daripada jantung.

(/73) /do Apakah pendarahan berhenti?

ARTERIAL PRESSURE

(/77) /me memberi tekanan dengan menutup aliran darah di bagian pembuluh darah korban.

(/73) /do Apakah pendarahan berhenti?

TOURNIQUET

Jika di tangan/kaki

(/78) /me mengambil tourniquet dan memasangnya 5cm di atas luka.

(/79) /me mengencangkan windlass sampai perdarahan berhenti.

(/80) /me memastikan tourniquet tetap pada posisi dan tidak longgar.

(/73) /do Terlihat pendarahan mulai dapat diatasi.

Jika di tubuh

(/81) /me mengeluarkan CRoC dari dalam ILS Bag.

(/82) /me merakit CRoC.

(/83) /me meletakkan CRoC di atas area pendarahan.

(/84) /me memposisikan kepala cakram CRoC menyentuh area pendarahan.

(/85) /me memutar T-Handle, memberikan tekanan hingga pendarahan berhenti.

(/86) /me memasangkan tali pengaman.
(/73) /do Terlihat pendarahan mulai dapat diatasi.
Lakukan ILS IV Lactated Ringers Solution kalau kehilangan banyak darah

📋ABC PROCEDURE

AIRWAY

Metode Umum (Head-Tilt Chin-Lift)
(/91) /me menempatkan diri di sisi kepala korban, memastikan posisi aman dan stabil.
(/92) /me meletakkan tangan kanan di atas dahi korban, lalu tangan kiri di bagian dagu korban.
(/93) /me menekan dahi korban secara perlahan sambil menarik dagu ke atas, melakukan head-tilt chin-lift untuk membuka jalan napas.
(/94) /me memastikan kepala tidak tertarik terlalu jauh ke belakang agar tidak menyebabkan cedera tambahan.
(/95) /me membuka sedikit mulut korban setelah airway terbuka.
(/96) /me mengambil flashlight dari ILS Bag lalu menyorot bagian dalam mulut korban.
(/97) /do Apakah ada halangan yang menggangu airway korban?
(Jika Iya)
(/98) /me mengambil tweezer dari ILS Bag, memastikan alat dalam kondisi bersih.
(/99) /me membuka mulut korban lebih lebar dan mencoba menjepit objek tersebut dengan hati-hati.
(/100) /me menarik objek keluar dari airway dengan gerakan perlahan agar tidak mendorongnya lebih dalam.
(/101) /do Terlihat objek telah keluar dari airway korban.
(/102) /me memastikan tidak ada sisa-sisa kecil yang tertinggal di airway korban.
(/103) /me membersihkan area mulut korban menggunakan gauze sterile dari ILS Bag.

Jika Cedera Kepala (Jaw-Thrust)
(/104) /me menempatkan diri tepat di atas kepala korban untuk melakukan jaw-thrust maneuver.
(/105) /me meletakkan kedua tangan di sisi rahang bawah korban, tepat di belakang sudut rahang.
(/106) /me mendorong rahang korban ke atas dengan stabil, membuka airway tanpa memberikan tekanan pada leher.
(/107) /me menggunakan kedua ibu jari untuk membuka mulut korban dengan perlahan.
(/108) /me mengambil flashlight dari ILS Bag lalu menyorot ke bagian dalam mulut korban.
(/109) /do Apakah terlihat ada objek yang menghalangi jalur napas korban?
(Jika Iya)
(/110) /me mengambil tweezer dari ILS Bag dan membuka mulut korban lebih lebar lagi.
(/111) /me menggunakan tweezer untuk menjepit objek yang berada di airway secara hati-hati.
(/112) /me menarik objek keluar sambil tetap melakukan jaw-thrust agar airway tetap terbuka.
(/101) /do Terlihat objek telah keluar dari airway korban.
(/102) /me memastikan tidak ada sisa-sisa kecil yang tertinggal di airway korban.
(/103) /me membersihkan area mulut korban menggunakan gauze sterile dari ILS Bag.

BREATHING

Tidak Ada Bleeding/Fracture di Torso

(/113) /me menarik perangkat ECG mendekat, lalu membuka panel sensor 12-lead.
(/114) /me mulai menempelkan elektroda satu per satu di area dada korban sesuai posisi standar.
(/115) /me memastikan semua lead menempel dengan baik, lalu menghubungkan kabel ECG ke unit monitor.
(/116) /me menyalakan perangkat ECG dan mengatur mode monitor.
(/117) /me memperhatikan tampilan monitor ECG yang menampilkan respiratory rate korban.
(/118) /do Berapa laju pernafasan yang terbaca pada monitor ECG? (12 - 20 Normal)

Ada Bleeding/Fracture di Torso

/me mendekatkan telinganya ke atas mulut korban sambil melihat ke arah dada korban lalu memperkirakan laju pernapasan korban.
/do Berapa jumlah pernapasan korban? (12 - 20 Normal)

Airway Ada Darah yang Tidak Berhenti

(/119) /me berdiri dan berjalan cepat menuju unit kendaraan.
(/120) /me mengambil oxygen outlet dari kompartemen unit dan membawanya menuju korban.
(/121) /me meletakkan oxygen outlet di samping korban.
/me memposisikan kepala korban ke posisi sniffing untuk membuka jalan napas.
/me mengambil laryngoscope lalu memasukkannya perlahan ke dalam mulut korban untuk memvisualisasikan pita suara.
/do Pita suara korban mulai terlihat dengan bantuan cahaya laryngoscope.
/me memasukkan endotracheal tube secara perlahan melewati pita suara menuju trakea korban.
/me mengembangkan cuff pada ET tube untuk mengamankan posisi dan mencegah kebocoran udara.
/me menyambungkan ET tube ke selang oksigen dari oxygen outlet di samping korban.
/do Aliran oksigen mengalir dengan baik melalui ET tube.
(/137) /do Apakah laju pernapasan korban terlihat membaik? (12 – 20 Normal)

Simple Face (Under 12)

(/119) /me berdiri dan berjalan cepat menuju unit kendaraan.
(/120) /me mengambil oxygen outlet dari kompartemen unit dan membawanya menuju korban.
(/121) /me meletakkan oxygen outlet di samping korban.
(/122) /me mengambil Simple Face Mask dari ILS Bag.
(/123) /me menyambungkan selang ke oxygen outlet dan mengatur aliran oksigen ke 5–10 L/min.
(/124) /me menempatkan masker pada wajah korban, menutupi hidung dan mulut dengan rapat.
(/125) /me mengaitkan tali masker ke belakang kepala korban agar stabil.
(/137) /do Apakah laju pernapasan korban terlihat membaik? (12 – 20 Normal)

Nasal Cannula (Over 12)

(/119) /me berdiri dan berjalan cepat menuju unit kendaraan.
(/120) /do Terlihat petugas sedang membuka kompartemen oksigen kemudian mengambil oxygen outlet beserta regulator.
(/121) /me sambil berjalan cepat dengan membawa oxygen outlet kembali ke sisi korban dan memasangnya pada perangkat oksigen yang akan digunakan.
(/127) /me mengambil nasal cannula dari ILS Bag dan menghubungkannya pada oxygen outlet.
(/128) /me mengatur aliran oksigen pada 2–4 liter per menit.
(/129) /me menempatkan dua ujung nozzle cannula ke dalam lubang hidung korban.
(/130) /me melingkarkan tali cannula ke belakang telinga korban dan mengencangkannya agar tidak lepas.
(/137) /do Apakah laju pernapasan korban terlihat membaik? (12 – 20 Normal)

Non-Rebreather Mask (Abnormal/Extreme)
(/119) /me berdiri dan berjalan cepat menuju unit kendaraan.
(/120) /do Terlihat petugas sedang membuka kompartemen oksigen kemudian mengambil oxygen outlet beserta regulator.
(/121) /me sambil berjalan cepat dengan membawa oxygen outlet kembali ke sisi korban dan memasangnya pada perangkat oksigen yang akan digunakan.
(/132) /me mengambil Non-Rebreather Mask dari ILS Bag dan memastikan reservoir bag telah mengembang.
(/133) /me menghubungkan selang ke oxygen outlet dan mengatur aliran oksigen ke 10–15 L/min.
(/134) /me menempatkan NRB mask pada wajah korban dengan posisi rapat.
(/135) /me memastikan katup satu arah bekerja dan reservoir bag tetap terisi.
(/136) /me mengaitkan tali ke belakang kepala korban agar mask tidak bergeser.
(/137) /do Apakah laju pernapasan korban terlihat membaik? (12 – 20 Normal)

CIRCULATION

Tidak Ada Bleeding/Fracture di Torso
(/138) /me menatap ke layar ECG, memantau grafik denyut jantung serta indikator heart rate.
(/139) /do Berapa denyut nadi per menit yang terbaca pada monitor ECG? (60 - 100 Normal)

Ada Bleeding/Fracture di Torso
/me meletakkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke carotid artery korban untuk memeriksa denyut nadinya.
/do Berapa denyut nadi per menit korban? (60 - 100 normal)
Kalau di atas 100 pakai NRB^ karena pasti bakal sesak nafas juga

CPR (Kalau gaada gejala abnormal di torso)
(/140) /me mengeluarkan BVM dari dalam ILS Bag.
(/141) /me memasangkan BVM di area hidung dan mulut korban dengan rapat.
(/142) /me memastikan seal mask tertutup sempurna.

(/143) /me meletakkan kedua telapak tangan di atas sternum korban.
.cpr
(/144) /me mulai memberikan 30 kompresi dada secara ritmis, menekan kuat dan dalam dengan kecepatan stabil.
(/145) /do Apakah ada perubahan pada ritme ECG atau respons korban? (60 - 100 Normal)

Cardiac Arrest / Resuscitation (Jika Belum Berhasil/ada gejala abnormal di torso)
(/146) /me berlari menuju unit kendaraan lalu membuka kompartemen medis.
(/147) /do Terlihat petugas mengambil AED dari dalam ambulans lalu kembali ke sisi korban.
(/148) /me meletakkan AED di samping korban dan menyalakannya.
(/149) /me membuka baju bagian dada korban hingga terlihat jelas area sternum.
(/150) /me memastikan permukaan dada korban kering.
(/151) /me meletakkan pads AED di atas dada korban lalu menekan tombol shock pada AED.
(/152) /do AED otomatis akan memberikan shock.
(/153) /me melihat monitor ECG dan mendapati ritme jantung mulai stabil kembali.
Jika Belum Berhasil Lanjut ILS (Atropine, jika Jantung: 0 Epinephrine)

💉 ILS DRUGS
SETUP IV (Lactated Ringer, Saline Solution, Naloxone)
(/161) /me membuka ILS Bag, mengambil jarum IV, catheter, dan antiseptik.
(/162) /me meraba-raba area kulit untuk mencari titik nadi lalu membersihkan area nadi korban.
(/163) /me menusukkan jarum IV perlahan ke pembuluh darah, memastikan flashback terlihat.
(/164) /me mendorong catheter masuk ke dalam pembuluh darah lalu mencabut needle safety device.
(/165) /me menempelkan plester untuk mengunci catheter pada kulit korban.

🧪 CAIRAN IV (Lactated Ringer(kantung): Hilang banyak darah)
(/166) /me mengambil kantong LR 500ml dari ILS Bag.
(/167) /me menyambungkan kantong LR ke IV line yang sudah terpasang.
(/168) /me membuka sedikit regulator untuk mengatur aliran cairan.
(/169) /do Cairan mulai mengalir masuk ke tubuh korban.

🧪 CAIRAN IV (Saline Solution(kantung): Dehidrasi, ini kalau sudah ambil gurney)
(/170) /me mengambil kantong Saline 500ml dari ILS Bag.
(/171) /me menggantungkan kantong saline di IV stand gurney.
(/172) /me mengatur aliran saline melalui tubing sambil memantau respon korban.

🫀 DEBAR JANTUNG (Atropine: Nadi abnormal/extreme menurun)
(/173) /me mengambil vial Atropine dari ILS Bag dan membuka tutupnya.

(/174) /me menyiapkan spuit kecil dan menarik dosis sesuai berat korban.
(/175) /me menyuntikkan Atropine ke otot korban dengan perlahan.
(/176) /me menarik jarum kemudian menekan area suntikan dengan kasa.
(/177) /me memantau ulang denyut nadi korban melalui pergelangan tangan.
(/178) /do Apakah ada perubahan pada denyut nadi korban?

🫀 DEBAR JANTUNG (Epinephrine: Henti jantung)

(/179) /me menyiapkan spuit dan menarik cairan epinephrine.
(/180) /me menyuntikkan Epinephrine ke otot korban.
(/181) /me kembali menekan tombol shock pada AED sambil memantau respon jantung.
(/178) /do Apakah ada perubahan pada denyut nadi korban?

🫀 DEBAR JANTUNG (Verapamil: Nadi terlalu tinggi/sakit kepala berat)

(/182) /me menyiapkan spuit untuk injeksi intramuscular.
(/183) /me menyuntikkan Verapamil ke otot korban.
(/184) /me memantau denyut nadi korban untuk menilai penurunan detak jantung.
(/185) /do Apakah ada perubahan pada denyut nadi korban?

💢 PEREDA NYERI (Ibuprofen)

(/186) /me mengambil dua pil Ibuprofen dari ILS bag.
(/187) /me memberikan pil Ibuprofen kepada korban.

🩻BONE FRACTURE PROCEDURE

CLOSE TANGAN BAGIAN ATAS (TRIANGULAR BANDAGE)

(/191) /me mengeluarkan Triangular Bandage dari ILS Bag dan memposisikan lengan korban dalam posisi diagonal untuk mengurangi pergerakan.
(/192) /me memasangkan Triangular Bandage ke bawah lengan yang patah dan belakang leher, mengaitkan ujung-ujungnya secara diagonal.
(/193) /me mengikat kedua ujung Triangular Bandage di belakang leher korban untuk memastikan lengan tetap stabil dan mencegah cedera lebih lanjut.

KEPALA (C-COLLAR)

(/194) /me memeriksa kondisi korban dan menentukan bahwa C-Collar diperlukan untuk menstabilkan bagian leher dan kepala korban.
(/195) /me mengeluarkan C-Collar dari ILS Bag.
(/196) /me melebarkan C-Collar dengan menarik bagian depan dan belakang, lalu memasangkannya ke leher korban dengan hati-hati.

OPEN - CLOSE TANGAN & CLOSE KAKI (VACUUM SPLINT)

(/197) /me mengeluarkan Vacuum Splint dari ILS Bag.

(/198) /me membuka katup Vacuum Splint dan memasangnya dengan hati-hati pada titik lokasi yang patah pada korban.
(/199) /me memastikan bahwa splint terpasang dengan baik dan aman.

OPEN KAKI (TRACTION SPLINT)

(/200) /me mengambil Traction Splint dari Unit Kendaraan lalu membawanya ke dekat korban.
(/201) /me membuka strap Traction Splint satu persatu lalu memasangnya ke kaki korban.
(/202) /me menutup strap satu persatu dan memastikan kaki korban tidak dapat bergerak.

GRAZE PROCEDURE (LUKA LECET)

(/211) /me mengeluarkan satu botol kecil Saline Solution dari ILS Bag.
(/212) /me menuangkan Saline Solutionnya ke atas cotton pad.
(/213) /me mengeluarkan gauze pad lalu meletakkannya di atas luka dan memerbannya perlahan.

BRUISE PROCEDURE (MEMAR)

(/214) /me memeriksa kembali kondisi korban dengan teknik palpasi untuk mencari adanya luka memar.
(/215) /do Apakah terdapat luka memar/bruise pada tubuh korban?
(/216) /me mengambil ICP serta kain tipis dari ILS Bag lalu membungkus ICP dengan kain tipis.
(/217) /me meletakkan ICP yang dibalut kain tersebut di atas luka memar korban selama 15 menit.
(/218) /do 15 menit telah berlalu, ICP telah mencair.
(/219) /me mengangkat ICP dari tubuh korban lalu memasukan ICP ke ILS Bag.
(/220) /me mengambil elastic bandage dari ILS Bag lalu menaruhnya di luka korban dan menutupnya.

🚑PATIENT LOAD PROCEDURE

(/37) /me merapikan peralatan yang digunakan lalu mengambil gurney dari dalam Unit Kendaraan dan membawanya ke samping korban.
(/38) */removebarrier*
(/39) */gurney get 2*
(/40) /me memindahkan korban ke atas gurney lalu mendorongnya sampai ke Unit Kendaraan dan memasukkan korban dengan hati-hati.
/gurney load [id]
(/41) */gurney return*
Loaded1 (/31): /r ~ Status-7e, bring one victim down with Fracture, please prepare ER. Now heading to 10-20 PBH with ETA 4 Minutes.
Loaded1 (/32): /r ~ Status-7e, bring one victim down with GSW, please prepare ER. Now heading to 10-20 PBH with ETA 4 Minutes.
Loaded1 (/33): /r ~ Status-7e, bring one suspect down with GSW, please prepare ER. Now heading to 10-20 PBH with ETA 4 Minutes.

Loaded1 (/34): /r ~ Status-7e, bring one suspect down with Fracture, please prepare ER. Now heading to 10-20 PBH with ETA 4 Minutes.

🏥**SAMPAI DI PBH**

OnHospi (/35): /r ~ Status-8 on 10-20 PBH.

(/42) /me menurunkan korban dengan perlahan dan membawanya ke Emergency Room untuk ditangani lebih lanjut oleh tim dokter.

Alt -> Eject

/bed [id]

RTB (/36): /r ~ reporting 10-99 from Last Scene, now RTB to 10-20 DFS.

📝**DOCTOR REPORT**

LOC A/V/P/U, GSW/Open Fracture on Right Leg, ABC Normal

RPLY NPC JIKA TAK ADA DOKTER

/dropbody

/bed [id]

.mechanic

(/231) /do Dokter dan Tim Trauma mulai memasuki ruang operasi.

(/232) /do Dokter memulai tindakan operasi selama beberapa jam.

(/233) /do Setelah 3 jam apakah kondisi pasien membaik?

Kondisional aja

/do Security memasuki ruang operasi untuk memeriksa barang bawaan korban.

/do Apakah pasien membawa barang ilegal/terlarang?

Jika operasi berhasil

/stabilize [id]

Tunggu muncul notif.

/heal [id]

RP Bill

((Percakapan buat bayar di lobi))

((Minta ID Card))

(/234) /me menerima ID Card yang diberikan dengan tangan kanan dan melakukan pengecekan.

(/235) *.prop_tablet2*

/hospitalbill search [patient name]

((kalau ada tunggakan suruh bayar dulu))

(/236) /me membuatkan bill sesuai dengan kebutuhan dan mencetaknya.

/medicreport [id]

(/237) /me memberikan kembali ID Card serta Bill kepada pasien.

👮OCD TAKEOVER

📻RADIO

Takeover OCD: /r Fire Alrik takover OCD right now.
Release OCD: /r Fire Alrik releasing OCD now.
Tanya lokasi: OCD to All/Field unit. Please 10-21.
Dispatch: OCD to [*nama_unit*]. Please 10-97 to RID 9 with CODE-3, how copy?
Self Dispatch: OCD under [*nama_unit*] Self Dispatch and taking Status-5e heading to RID 4 with CODE-3, ETA 4 Minutes.
Dep. Radio part1: Fire @ to LSPD/LSSD.
Dep. Radio part2: Please send your unit to Hospital, we have patient bring an ilegal items.
Dep. Req part1: What units are needed and how many casualties are there?
Dep. Req part2: Alright, please drop beacon there.
Dep. Req part3: All units have been dispatched and will arrive there in 2 minutes.

💀RP CORONER (RPLy)

📻RADIO

MEDRequest (/238): /r ~ to OCD. Requesting 10-70 MED Unit at 10-20 Legion.

(/239) /do Unit Coroner telah tiba di lokasi korban berada.
(/240) /do Tim Coroner membuka pintu belakang unit Coroner dan mengeluarkan stretcher dengan body bag di atasnya.
(/241) /do Tim Coroner bersama-sama mengangkat tubuh korban dengan hati-hati dan meletakkannya di dalam body bag lalu menutup resletingnya rapat-rapat.
(/242) /do Tim Coroner mengangkut korban ke dalam unit Coroner dan pergi meninggalkan lokasi kejadian.

💀RP CORONER (Possible CK Scene)

📻RADIO

OnLocation: /r ~ Status-6 on 10-20 Legion.

(/243) /me mengambil N-Gloves dan masker dari ILS Bag lalu mengenakannya.
(/244) /me berjongkok di samping tubuh korban, memeriksa denyut nadi dan pupil mata.
(/245) /me tidak menemukan adanya tanda-tanda kehidupan, tubuh korban sudah tidak bernyawa.
(/246) /me menghela napas pelan, lalu mencatat waktu kematian di clipboard.
(/247) Huh... beliau sudah pergi, semoga Tuhan menaungi jiwanya dengan terang dan ketenangan.
(/248) .prop_clipboard

(/249) /me membuka pintu belakang unit Coroner, mengeluarkan stretcher dengan body bag di atasnya.
(/250) /me meletakkan gurney di samping tubuh korban dengan hati-hati.
(/251) /me membuka body bag perlahan, memastikan dalam keadaan bersih.
((RP mintol bantu angkat))
(/252) /me mengangkat tubuh korban dengan hati-hati dan meletakkannya di dalam body bag.
(/253) /me menutup resleting body bag dengan perlahan hingga rapat.
(/254) /me mendorong stretcher ke arah unit Coroner, memasukkan stretcher ke dalam unit lalu mengunci posisinya agar tidak bergeser.
(/255) /me menutup pintu belakang unit Coroner rapat-rapat.

🔥🧯 RP MVA

((Referensi Anim))
.inspect
.mechanic
.mechanic3

🔎VEHICLE IDENTIFY

Jika korban di dalam mobil, kalau nggak ya RP sendiri.
(/256) /me mengidentifikasi kendaraan di depannya.
(/257) /do Apakah ada kebocoran oli atau bensin?
(/258) /me mengambil Crosslay Line dari Compartement Engine, lalu memutar katub ke mode Foam Class B.
(/259) /do Dimana sumber api?
(/260) /me mengarahkan Nozzle ke kap kendaraan yang mengeluarkan api, menyemprotkan air ke kap kendaraan tersebut.
(/261) /do Terlihat api telah padam setelah disemprotkan air.
(/262) /me membawa Crosslay Line kembali ke arah Engine lalu menaruhnya di Compartement Engine.
Mematikan Mesin
(/263) /me mengambil Halligan Bar dan Plier dari Compartement Truck lalu membawanya ke arah mobil korban.
(/264) /me membuka Kap mobil dengan menggunakan Halligan bar.
(/265) /do terlihat kap mobil mulai terbuka.
(/266) /me memotong Power Supply dari aki menggunakan Plier.
(/267) /do Mesin mobil akan mati setelah Power Supply dan aki dipotong menggunakan Plier.
(/268) /me mengambil Halligan Bar dan Plier, membawanya ke arah Truck dan menaruhnya di Compartement Truck kembali.

🚁VERTICAL RESCUE

📻RADIO

Permission: /r Fire Alrik to OCD. Requesting permission for duty as Pilot of ~.

Pilot Report: /r Fire Alrik now duty as Pilot of ~ and unavaliable for Vertical Rescue Training.

Takeoff Report: /r Fire Alrik under ~ airborne from DFS helipad, alt 400, for Vertical Rescue Training VFR heading North on departure, over.

Dep. Report: /d ATC, ~ airborne from DFS helipad, alt 400, for Vertical Rescue Training, VFR, heading North on departure, squawk 2222.

Landed Report: /r ~ has fully landed on DFS helipad, full-stop.